Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 945 - Bairro: Centro - CEP: 96810144 - Fone: (51) 3711-2952 - Email: frsantcruz1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003697-69.2021.8.21.0026/RS

AUTOR: LIRIA WINK (CURADOR)

AUTOR: DARCI RUDI ASSMANN (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

DARCI RUDI ASSMANN, qualificado nos autos, ajuizou **Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que foi diagnosticado com LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA, CID 10 nº C 91.0, com critérios de doença avançada, motivo pelo qual necessita tomar diariamente o medicamento IMBRUVICA – IBRUTINIBE 140 mg, de uso contínuo. Discorreu acerca da necessidade de utilização do medicamento. Afirma que não possui condições de arcar com os custos do fármaco. Fundamenta seu pleito nos art. 6º, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, inciso II da Constituição Federal, bem como no art. 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no art. 2º e art. 6º da Lei nº 8.080/90. Colaciona decisões jurisprudenciais a corroborar a sua tese. Requer, em sede de tutela antecipada, seja determinado que o requerido forneça o medicamento supramencionado, ou então o valor necessário para a aquisição do fármaco. Ao final, requer a procedência da ação, tornando definitiva a tutela antecipada concedida. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o que já fora deferido. Junta documentos (evento 1).

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (evento 19).

O autor informou a dispensação administrativa do medicamento (evento 41).

Citado, o réu apresentou contestação, onde inicialmente discorreu acerca da fixação de teses pelos tribunais superiores e necessidade de observação no caso concreto. Teceu considerações sobre o alto custo do tratamento. Alegou o fato de o medicamento não constar da lista do SUS. Aduziu acerca da política nacional de prevenção e controle do câncer, dissertando sobre o tratamento no âmbito do SUS. Sustentou a responsabilidade da União, postulando pela sua inclusão no polo passivo do presente feito. Requereu a improcedência da demanda. Juntou documentos (evento 47).

Houve réplica (evento 54).

Foi indeferida a inclusão da União no polo passivo da demanda (evento 61).

Instadas, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas (eventos 67 e 69).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 74).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

RELATEI.

DECIDO.

Em um primeiro momento, entendo oportuno tecer algumas considerações sobre o fármaco postulado através da presente demanda, pois mesmo tratando-se de medicamento não constante na lista do Sistema Único de Saúde, tenho que persiste a obrigação do Ente Público ora demandado em fornecer o medicamento, ainda que não seja daqueles constantes das listas do SUS, para tratamento da doença que acomete a parte autora.

Isso porque a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não pode excluir a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever estabelecido e previsto na Constituição Federal, assim como também não pode se sobrepor ao princípio maior da Carta Constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS****. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNICA DO FÁRMACO NO RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. VERBA HONORÁRIA AO FADEP. 1. Tratando-se de direito à saúde, a responsabilidade recai, solidariamente, à União, ao Estado e aos Municípios. Precedentes das Cortes Superiores.* ***A ausência dos medicamentos postulados em tal lista não tem o condão de desonerar o ente público de suas obrigações constitucionais e legais em relação à saúde. 2. A forma de organização do SUS e a ausência de inclusão de medicamentos em listas prévias não podem obstaculizar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados. 3. Inexistente afronta ao princípio da reserva do possível, uma vez que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.*** *4. O valor arbitrado em sentença deve ser mantido, apesar de estar além dos parâmetros desta Câmara. Todavia, por não*

haver insurgência do ente municipal sobre o assunto, descabe ao julgador reduzir a verba de ofício. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (Apelação Cível Nº 70072874654, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 20/04/2017)

Ademais, oportuno referir que já houve o julgamento do Resp 1.657.156/RJ, referente ao Tema 106 do STJ, o qual analisou caso paradigma, restando a decisão assim ementada:

*ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. **4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;** Documento: 82869018 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 04/05/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.*

Todavia, há que se acrescentar que houve a modulação dos efeitos da decisão, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento.

Dito isso, passo à análise do mérito propriamente dito.

Objetiva a parte autora, através da presente demanda, a condenação do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de que seja este compelido ao fornecimento do medicamento IMBRUVICA – IBRUTINIBE 140 mg, de forma contínua, afirmando que necessita fazer uso do mesmo em razão de ter sido diagnosticado com LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA, CID 10 nº C 91.0.

Destaco que a Carta da República positiva, em seu artigo 196 e seguintes, diz que a saúde é um direito universalizado e constitui dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco doença e ao acesso integral às ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora atomizada, através de um sistema único, no qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios.

Desse modo, estabelece-se um regime de responsabilidade solidária entre todos os entes federados na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados, em que pese tenham as pessoas de direito público procedido dentro da gestão e em face da atenção básica à saúde, ao escalonamento de responsabilidades, às quais, em face do credor da prestação se mostra irrelevante, remanescendo, sim, o dever constitucional de atendimento.

Assim, a responsabilidade pela saúde pública, imposta pela Constituição Federal, não pode ser considerada de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação, podendo, pois, a parte, ajuizar a ação contra qualquer um deles, daí de se reconhecer a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul no presente caso.

Outrossim, a pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal [1], sendo que a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido.

A matéria já foi objeto de acórdão julgado pelo regime do art. 543-B do CPC/1973 pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ***DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA****. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.* ***O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)*

Neste sentido também a jurisprudência do TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. ***DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SAÚDE PUBLICA.*** *Os fundamentos invocados pelo recorrente para sustentar a ilegitimidade passiva dos entes públicos confundem-se com o mérito da causa. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, considerado lato sensu.* ***Compete ao Poder Público, independendo da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade por cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes federativos. Tocante à eficácia da norma constitucional do referido artigo, sem dúvida auto-aplicável, de eficácia plena, sendo desnecessária regulamentação por versar sobre direito fundamental, logo, de aplicação imediata e intensidade máxima. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário.*** *Para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que a medicação, procedimento ou tratamento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que o trata. De regra, não há que se atender a estudos e sugestões de substituição dos remédios emitidos pela respectiva secretaria de saúde, em detrimento*

da prescrição realizada pelo médico da paciente. O escopo preponderante da administração pública, na espécie, é o barateamento do tratamento e o almejo maior do profissional que atende o enfermo é o melhor para sua saúde. Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas, não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70074446170, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 05/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ***DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.*** *HONORÁRIOS AO FADEP. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município desacolhida.* ***Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. 2. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.*** *3. O fato do tratamento não constar na lista de competência do Município não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 4. A ausência de previsão orçamentária e reserva do possível são argumentos que não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde, não podendo ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna. 5. Correta a sentença ao condenar o Município a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que não configurado o instituto da confusão entre credor e devedor, previsto no art. 381 do CC. 6. Reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do FADEP, para adequar aos parâmetros adotados pela Câmara, observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. 7. Remessa Necessária conhecida de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA A SENTENÇA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. (Apelação Cível Nº 70074796251, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 04/09/2017)*

Pois bem.

A Carta Constitucional erigiu o direito à saúde à categoria de direito social conforme se constata pela redação do artigo 6º:

Artigo 6º: São direito sociais a educação, a ***saúde****, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

Assim, pela prestação do direito social à saúde, se está concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Outrossim, o artigo 196 da Constituição Federal corrobora a proteção à saúde, estabelecendo-a como um dever do Estado, assegurando a todos os cidadãos o acesso à saúde de forma universal e igualitária. Eis a redação do artigo:

Artigo 96: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse, inclusive, é o entendimento da jurisprudência a qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira do ente público. Atendimento preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em filas nem sujeitar-se aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os princípios da isonomia e da legalidade. Honorários advocatícios. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 20 §§ 3º e §4º do CPC/73, correspondentes ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/15. Custas e despesas processuais. As pessoas jurídicas de direito público pagam despesas judiciais, com a ressalva feita em relação aos oficiais de justiça para o Estado (ADI nº 70038755864). Considerando o efeito repristinatório conferido pelo Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/10, determinando a aplicação do art. 11, alínea a e parágrafo único, com a redação original dada pela Lei Estadual nº 8.121/85, é incabível a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais, o que apanha as suas autarquias. Por sua vez, conforme mesmo dispositivo legal repristinado, o Município paga as custas da parte que lhe couber por metade, o que inclusive já foi alvo de regulamentação pela egrégia Corregedoria-Geral da Justiça no Ofício-Circular nº 003/2014. Ao depois, não se aplica o disposto na Lei 14.634/2014, notadamente considerando a orientação expressa no Ofício-Circular nº 060/2015 da Corregedoria Geral de justiça, no sentido de que, para os processos ajuizados antes de 15 de junho de 2015, as custas e despesas serão cobradas conforme o Regimento de Custas previsto na Lei 8.121/85. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073929580, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 14/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Cerceamento de defesa. É dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do parágrafo único do artigo 370 do novo Código de Processo Civil. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Pareceres em tese elaborados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e pelo Departamento Médico Judiciário (DMJ). A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para improcedência da alegação de que os fármacos requeridos não seriam indicados para o quadro clinico da parte autora, bem como para desautorizar a pretensão de substituí-los com base em conclusões obtidas sem estudo do caso concreto. Ademais, parecer em tese não substitui perícia, assim como perícia

não se faz por amostragem. Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Descabida a tese do ente público no sentido de que a parte autora não preencheu os requisitos elencados no Protocolo Clínico emitido pelo Ministério da Saúde quanto à utilização dos medicamentos descritos na inicial, para o tratamento da patologia que lhe acomete, uma vez que os fármacos solicitados foram indicados pelo seu médico, o qual tem condições técnicas de indicar o tratamento adequado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073860645, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 13/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL NO STF Nº 855178/SE. MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER DO ESTADO. CUSTAS, DESPESAS E EMOLUMENTOS. LEI Nº 13.471/10. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 70038755864 E INCIDENTE Nº 70041334053. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDUÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Preliminar de ilegitimidade passiva Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a solidariedade dos entes federados na efetivação do direito à saúde, sem atribuições exclusivas e excludentes, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada. Art. 196, caput, e art. 198, § 1º, da Constituição da República; art. 7º, XI, da Lei Federal nº 8.080/90 e art. 241 da Constituição Estadual. Repercussão Geral nº 855.178/SE do STF. Mérito I - O direito à saúde é direito social e dever do Estado - arts. 6º e 196 da CF/88 -, e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do art. 5º, §1º, da Constituição da República. II - Desnecessária a previsão em lista de medicamentos essenciais ou especiais ou excepcionais da Administração, pois atos normativos não se sobrepõem à norma constitucional. III - A ausência de previsão administrativa - item não relacionado como afeto à saúde pela ANVISA - não tem o condão de revogar norma constitucional de incidência imediata. IV - Em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/10, pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 70038755864 e do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053, não subsiste a isenção do Estado do Rio Grande do Sul no pagamento das custas, emolumentos e despesas processuais, com exceção das despesas destinadas à condução dos Oficiais de Justiça. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No mais, sentença mantida em reexame necessário. (Apelação Cível Nº 70063316426, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PUBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Medicamentos: Brometo de Tiotropio (Spiriva) 18mcg e Fumarato de Formoterol + budesonida (Foraseq) 12+400mcg. Enfermidade: Enfisema Pulmonar. Custo: não informado. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Ausentes os requisitos de nulidade de sentença constantes nos arts. 2º e 128 do CPC, não há falar em sentença extra petita. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA COMUM. ENTES FEDERADOS. A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, bem como pelas listas de medicamentos especiais e excepcionais, já que se impõe ao Poder Público realizar todas medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde. Assim, presente a legitimidade passiva na demanda. LISTA. RESTRIÇÃO. DESCABIMENTO. MEDICAMENTO INDICADO. FORNECIMENTO. Descabe restringir a responsabilidade do Poder Público ao fornecimento dos medicamentos presentes nas listas do SUS, já que implicaria verdadeira mitigação da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, devendo, portanto, ser prestados os medicamentos indispensáveis a preservação do mínimo existencial. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. Não há nos autos prova de que o Poder Público não tenha condições de custear a cirurgia postulada pela parte autora ou que existam outras prioridades que com o seu custeio acabariam por ficar desatendidas. Tal situação, no qual o Poder Judiciário determina o fornecimento de procedimentos médicos de que a autora necessita, não fere o princípio da legalidade, pois tal só ocorre porque o Executivo deixa de assegurar a garantia do direito à saúde aos cidadãos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048431787, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 05/09/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: SULFASSALAZINA 500MG (AZULFIN). ENFERMIDADE: COLITE ULCERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado e o Município são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos, independentemente de qual seja este, tendo em vista que o art. 23 da CF prevê como competência comum da União, Estado, Distrito Federal e Município, cuidar da saúde. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. Não cabe condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em face da ocorrência do instituto da confusão. REEXAME NECESSÁRIO. Há conhecer de ofício do reexame necessário, tendo em vista que a condenação é ilíquida e se enquadra na previsão do art. 475, I, do Código de Processo Civil, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que se trata de medicação de uso contínuo. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal. A assistência à saúde é direito público subjetivo, independentemente de contribuição. Todos têm direito subjetivo à saúde, podendo exigi-lo do Estado e Município, visto que a saúde é direito do cidadão e dever dos Poderes Públicos e da sociedade. APELO PROVIDO EM PARTE E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. (Apelação Cível Nº 70030879852, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 16/09/2009)

Ademais, é mister que se diga que o direito à saúde não está entre as normas de caráter meramente programáticas, mas sim caracteriza-se como regra de aplicação imediata capaz de viabilizar a necessária concretização do sistema constitucional vigente.

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu artigo 2º, estabelece que *"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício."*

No caso em tela, a necessidade da utilização contínua do medicamento IMBRUVICA – IBRUTINIBE 140 mg, de forma contínua, pela parte autora, está comprovada pelo laudo médico acostado com a exordial e comprova a necessidade e a eficácia do medicamento postulado em relação à doença do requerente.

Outrossim, a hipossuficiência econômica do demandante restou cabalmente comprovada nos autos.

De outra banda, inexiste óbice à possibilidade de fornecimento dos fármacos postulados pelo nome comercial por outro, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, desde que na mesma quantidade e dosagem prescritas e com base no princípio ativo do postulado na inicial. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REMESSA NECESSÁRIA. ***DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS.*** *REMESSA NECESSÁRIA. CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. EXEGESE DO § 3º DO ART. 496 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME OBRIGATÓRIO. Não se conhece do reexame necessário, nas ações visando prestações positivas de saúde, quando o valor anual do medicamento/tratamento postulado, equivalente ao valor da condenação ou do proveito econômico resultante da lide, for inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados e Municípios das Capitais, e 100 (cem) salários mínimos para os demais Municípios. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Ao juiz é conferido o poder geral de instrução do processo, "ut" art. 370 do*

NCPC. É desnecessário expedir ofício à Receita Federal visando à obtenção de informações quanto à condição financeira da parte autora, quando possível constatar de logo que presumivelmente carece de recursos financeiros para adquirir os fármacos postulados em juízo, pois litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública, cujo atendimento sabidamente é voltado à parcela mais necessitada da população. Ademais, as condições pessoais da postulante denotam a carência de recursos financeiros. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. "A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles." (excerto do RE 855.178, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-03-2015). ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. A outro turno, as normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. O direito à saúde, erigido à categoria de preceito fundamental pela Constituição Federal, prepondera sobre o princípio da reserva do possível, cuja aplicação, tem sido relativizada pelo Supremo Tribunal Federal, em situações como a dos autos. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. Viável o fornecimento de medicamento genérico de mesmo princípio ativo daquele requerido pelo nome comercial, desde que apto a atingir idêntica finalidade.*** *REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O recebimento de medicação contínua não se condiciona à checagem periódica da saúde da demandante, sendo apenas exigível a renovação da prescrição médica. (...) (Apelação e Reexame Necessário Nº 70071333579, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 25/05/2017)*

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.*** *REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor anual do tratamento, equivalente ao valor da condenação, for inferior a 100 salários mínimos. BLOQUEIO DO TRATAMENTO DA PARTE AUTORA NO SISTEMA AME. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A inovação da tese em recurso é vedada porque ofende as garantias do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Caso em que a arguição suscitada pelo apelante constitui argumento novo, ensejando verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.* ***FORNECIMENTO DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. Reconhecimento da possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo.*** *REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O tratamento poderá resultar em melhora do estado de saúde da parte, mas esta verificação é da competência de seu médico, sendo apenas exigível a renovação da prescrição médica. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70073281743, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/05/2017)*

Ainda, tenho que não merece acolhimento o pedido do Estado quanto à realização de exames periódicos para efeito de comprovar a permanência da necessidade do recebimento dos medicamentos, na medida em que a análise da necessidade de manutenção do tratamento, cabe ao médico assistente da parte autora, sendo apenas necessária a renovação da prescrição médica, posto que o fornecimento de medicamento é condicionado à sua apresentação.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REMESSA NECESSÁRIA. ***DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS.*** *REMESSA NECESSÁRIA. CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. EXEGESE DO § 3º DO ART. 496 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME OBRIGATÓRIO. Não se conhece do reexame necessário, nas ações visando prestações positivas de saúde, quando o valor anual do medicamento/tratamento postulado, equivalente ao valor da condenação ou do proveito econômico resultante da lide, for inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados e Municípios das Capitais, e 100 (cem) salários mínimos para os demais Municípios. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Ao juiz é conferido o poder geral de instrução do processo, "ut" art. 370 do NCPC. É desnecessário expedir ofício à Receita Federal visando à obtenção de informações quanto à condição financeira da parte autora, quando possível constatar de logo que presumivelmente carece de recursos financeiros para adquirir os fármacos postulados em juízo, pois litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública, cujo atendimento sabidamente é voltado à parcela mais necessitada da população. Ademais, as condições pessoais da postulante denotam a carência de recursos financeiros. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. "A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles." (excerto do RE 855.178, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-03-2015). ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. A outro turno, as normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. O direito à saúde, erigido à categoria de preceito fundamental pela Constituição Federal, prepondera sobre o princípio da reserva do possível, cuja aplicação, tem sido relativizada pelo Supremo Tribunal Federal, em situações como a dos autos. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. Viável o fornecimento de medicamento genérico de mesmo princípio ativo daquele requerido pelo nome comercial, desde que apto a atingir idêntica finalidade.* ***REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O recebimento de medicação contínua não se condiciona à checagem periódica da saúde da demandante, sendo apenas exigível a renovação da prescrição médica.*** *(...) (Apelação e Reexame Necessário Nº 70071333579, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 25/05/2017)*

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.*** *REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor anual do tratamento, equivalente ao valor da condenação, for inferior a 100 salários mínimos. BLOQUEIO DO TRATAMENTO DA PARTE AUTORA NO SISTEMA AME. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A inovação da tese em recurso é vedada porque ofende as garantias do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Caso em que a arguição suscitada pelo apelante constitui argumento novo, ensejando verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. FORNECIMENTO DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. Reconhecimento da possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo.* ***REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O tratamento poderá resultar em melhora do estado de saúde da parte, mas esta verificação é da competência de seu médico, sendo apenas exigível a renovação da prescrição médica.*** *REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70073281743, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/05/2017)*

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ***SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.*** *RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 2. Descabe o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira quando não autorizado pelo médico assistente a possibilidade do fornecimento na forma genérica. 3.* ***Não se mostra razoável exigir a realização de exames periódicos, porquanto a natureza da demanda é de obrigação de fazer, e a pretensão da parte autora está baseada em laudo médico elaborado pelo profissional responsável por seu tratamento. 4. Além disso, a enfermidade diagnosticada mantém-se sob controle com a medicação indicada, impondo a continuidade do uso do fármaco.*** *5. Remessa Necessária conhecida de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. (Apelação Cível Nº 70072990781, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/05/2017)*

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,*** *EXAME, TRATAMENTO OU CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. (...)* ***REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS. DESNECESSIDADE. Não é necessária a realização de exames periódicos pela parte autora para a manutenção do tratamento, bastando a prescrição médica atualizada.*** *RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. FORTE ART. 557, CAPUT, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70049162654, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/11/2013)*

Há que se acrescentar, ainda, que os laudos médicos acostados ao feito comprovam a necessidade da utilização do medicamento.

Em vista de tais circunstâncias e considerando, especialmente, a comprovação da necessidade do uso contínuo do medicamento pela parte autora e da sua carência econômica, outro caminho não vislumbro à presente demanda senão a sua procedência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por DARCI RUDI ASSMANN nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que move em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para o fim de DETERMINAR ao Requerido o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento IMBRUVICA – IBRUTINIBE 140 mg, de uso contínuo, enquanto perdurar a patologia e se fizer necessário, facultada a possibilidade de utilização da Denominação Comum Brasileira, conforme determinação legal, para a identificação dos medicamentos, desde que não implique alteração da dose e das substâncias que constituem o princípio ativo dos medicamentos, ou, ainda, garantir-lhe valor em dinheiro equivalente para fazer frente a aquisição de tais medicamentos em rede privada.

Pelos mesmos motivos expostos acima, mantenho e confirmo a antecipação de tutela deferida no feito.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do autor, que estipulo em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §8°, do CPC[2]. Acerca das custas, considerando a redação original da Lei Estadual n.º 8.121/85 e as orientações contidas no Ofício-Circular n.º 003/2014 CGJ, o Estado está isento do pagamento das custas processuais e dos emolumentos, contudo, arcará com as despesas processuais, exceto a condução de Oficial de Justiça.

Como a condenação não tem valor certo, aplica-se a Súmula 490 do STJ, de tal sorte que não havendo recursos voluntários, os autos deverão ser encaminhados ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

1 Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

2APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE *MEDICAMENTO*. ÓBITO SUPERVENIENTE. PEDIDO PROCEDENTE. *HONORÁRIOS* ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, *Estados* e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. *HONORÁRIOS* ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Em se tratando de ação em que visada dispensação de tratamento de saúde de que necessita o cidadão desvalido, consistente na dispensação de fármaco, negada administrativamente pelo ente público réu, **pertinente a fixação dos *honorários* advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8º, do CPC**. O valor saúde, inestimável, prepondera em relação ao aspecto econômico. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70085195998, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-09-2021)

Documento assinado eletronicamente por **JOSIANE CALEFFI ESTIVALET, Juíza de Direito**, em 21/10/2021, às 21:54:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10012065414v2** e o código CRC **9775b100**.